

9. 71. Venetoclax (如 Venclexta) : (108/9/1、110/7/1、112/7/1、114/8/1、114/10/1)
1. 單獨使用於具有17p 缺失的慢性淋巴球性白血病(CLL) 成年患者。(108/9/1、112/7/1、114/10/1)
    - (1)限先前曾接受至少1種包括 alkylating agent 與 anti-CD20 (如 R-CVP、R-CHOP、rituximab 加 bendamustine 等)的治療2個療程以上仍惡化或復發者。
    - (2)開始使用前之疾病狀態需出現下列任一情形：
      - I. 進行性的血液相惡化至 Hb< 10.0gm/dL 或 PLT<100K/uL，且無其他原因可以解釋。
      - II. 脾臟腫大超過左肋骨下緣6cm。
      - III. 淋巴結腫大，最長徑超過10cm。
      - IV. 周邊血液淋巴球在2個月內增加50%以上，或倍增時間(doubling time)小於6個月。
      - V. 出現自體免疫併發症，且經類固醇治療無效。
      - VI. 出現具症狀的淋巴結外病灶。
    - (3)需經事前審查核准後使用，每3個月需再次申請。再次申請時需檢附療效評估資料，若未達 iwCLL(International Workshop on CLL)最新定義之 partial remission 或 complete remission，則不予給付。
    - (4) 在具有17p 缺失病人，venetoclax、acalabrutinib、ibrutinib 及 zanubrutinib 四者僅能擇一使用，唯有在出現無法忍受其副作用時方可互換。三者使用總療程合併計算，以全部24個月為上限。(108/9/1、112/7/1、114/10/1)
    - (5)每日至多處方4粒。
  2. 併用低劑量 cytarabine 或 azacitidine(除 Winduza 及 Azacitidine Lyophilized Inj 100mg" GBC" 以外)，使用於無法接受高強度化學治療之初診斷急性骨髓性白血病(AML)病人：(110/7/1、114/8/1)
    - (1)需具有下列 I. 或 II. 的條件之一：
      - I. 75歲以上。
      - II. 18歲以上但未滿75歲時，需 ECOG performance status 為2或3，且符合下列任一條件者：
        - A. 具有心臟衰竭治療病史，且 left ventricle ejection fraction (LVEF) <50%。
        - B. 具慢性肺部疾病史，且 DLCO<65%。
        - C. 具肝功能異常：Bilirubin level 在1.5-3.0倍正常值間。
    - (2)需未曾因骨髓化生不良症候群(myelodysplastic syndrome, MDS)接受過 azacitidine 治療者。
    - (3)需經事前審查核准後使用，每2個療程需再次申請；再次申請時需檢附療效評估

資料，若病情惡化應即停止使用。

- (4)若併用低劑量 cytarabine，每日至多處方6粒，最多給付4個療程。若併用 azacitidine 治療，每日至多處方4粒，最多給付6個療程。(110/7/1、114/8/1)